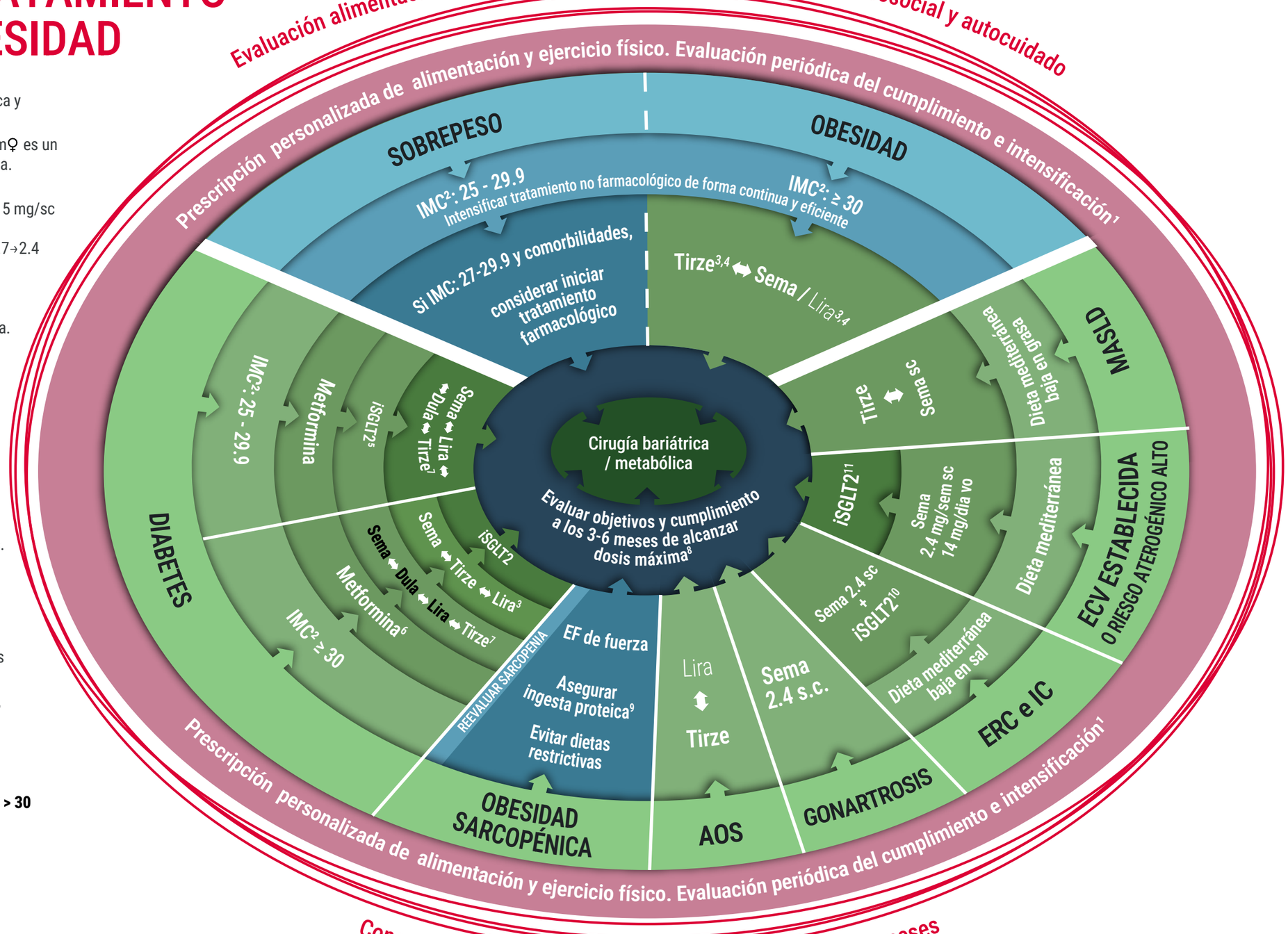
ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

Fundación redGDPS 2025

1. Incluye mayor control, registro y seguimiento de dieta hipocalórica y aumento de ejercicio físico.
2. La circunferencia de cintura (CC) de riesgo: > 102 cm ♂ y > 88 cm♀ es un indicador de adiposidad y requiere una intervención más intensiva.
3. Procurar alcanzar las dosis maximas que son las de obesidad:
   TIRZE: Tirzepatida. Incremento mensual: 2.5→5→7.5→10→12.5→15 mg/sc (dosis máxima semanal).
   SEMA SC: Semaglutida sc. Incremento mensual: **0.25→0.5→1**→1.7→2.4 hasta dosis máxima semanal.
   SEMA VO: Semaglutida oral. Incremento mensual: **1.5→4→9** mg (dosis máxima diaria).
   DULA: Dulaglutida. 1.5 mg → evaluar 0.75 mg/sem sc si no tolera.
   LIRA: Liraglutida. Incremento semanal:
   0.6→1.2→1.8→2.4→3 mg/dia sc (dosis máxima diaria).
4. Cambiar arGLP1 a tirzepatida o viceversa si intolerancia o falta de respuesta para el otro grupo.
5. Se justifica iniciar tratamiento con iSGLT2 ya que arGLP1 y tirzepatida no están financiados en pacientes con IMC < 30.
6. Valorar terapia dual de forma precoz con metformina + arGLP1.
7. Dosis financiadas en pacientes con DM2. Sema: semaglutida oral 1.5→4→9 mg/sem vo o 0.25→0.5→1 mg/sem sc. Dula: dulaglutida 1.5 mg/sem sc. Lira: liglutida 0.6→1.2→1.8 mg/dia sc.
8. Valorar realizar interconsulta para personas con obesidad con o sin DM2 y respuesta inadecuada al plan terapéutico propuesto.
9. Asegurar ingesta de proteínas > 1 g/Kg de peso, de alta calidad biológica
10. No olvidar bloqueo del sistema renina-angiotensina. En pacientes sin DM2 solo tienen indicación empagliflozina y dapagliflozina.
11. Objetivos de salud: mejorar el peso y/o circunferencia de cintura, así como otros factores de riesgo cardio-metabólico-renal.



DOSIS PARA DIABETES FINANCIADAS EN PACIENTES CON IMC > 30

Para ampliar información consultar otros algoritmos de Fundación redGDPS

CONDICIONANTES CLÍNICOS

ABREVIATURAS:

AOS: Apnea obstructiva del sueño, arGLP1: Agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón, CC: Circunferencia cintura, EF: Ejercicio físico, ECV: Enfermedad cardiovascular, ERC: enfermedad renal crónica, IC: insuficiencia cardiaca, IMC: Índice de masa corporal (kg/m²), iSGLT2: Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2, MASLD: Metabolic Dysfuntion Associated Steatotic Liver Disease (enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica), SC: Subcutáneo.

Revisado en diciembre de 2024

ALGORITMO redGDPS Fundación 2025 DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

PRINCIPALES CAUSAS DE OBESIDAD

PRIMARIAS

- **Neuroendocrinas**: Hipotiroidismo, S. Cushing, S. ovario poliquístico
- **Genéticas**: deficiencia leptina, síndromes genéticos, poligénica

FACTORES CONTRIBUYENTES

- **Alimentación inadecuada**
- **Sedentarismo**
- **Factores culturales y sociales**
- **Iatrogénia**: Fármacos, cirugía hipotalámica

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN DE LA OBESIDAD DE EDMONTON

(Metabólico, mecánico y mental)

Estadio 0
Ausencia de factores de riesgo.

Estadio 1
Factores de riesgo subclínicos. Limitación leve.

Estadio 2
Enfermedad crónica establecida relacionada con la obesidad. Limitación moderada.

Estadio 3
Daño de un órgano diana. Limitación significativa.

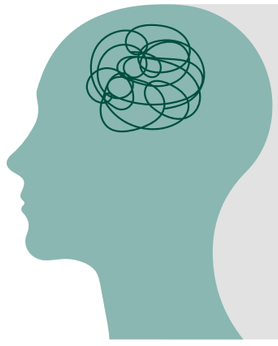
Estadio 4
Discapacidad y limitación funcional graves.

HISTORIA CLINICO NUTRICIONAL

- **Historia de la obesidad**
- **Tratamientos farmacológicos** concomitantes previos y actuales
- **Factores condicionantes** (si los hubiera) de la ganancia de peso (embarazo, cambio de hábitos…)
- **Hábitos alimentarios**
- **Actividad física**
- **Consumo de tóxicos**



VALORACION PSICOLOGICA. ESTIGMA



- Comunicación adecuada y empática del diagnóstico
- Atención centrada en la persona que vive con obesidad
- Valoración psicosocial y motivacional
- Evaluar el rechazo interiorizado y del entorno
- Evitar la estigmatización por el profesional sanitario

TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO



- Acompañamiento hacia una alimentación saludable y evitar el sedentarismo
- Ejercicio físico personalizado en función de actividad previa realizada al menos 2-3 días semana combinando ejercicio aeróbico, fuerza y equilibrio.
- La intervención dependerá del grado de obesidad, de las comorbilidades asociadas y de la respuesta individual.

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO



- El inicio del tratamiento farmacológico se hará en cada grupo después de una valoración integral del paciente.
- El Orlistat aunque autorizado y comercializado es menos efectivo y puede considerarse como alternativa en caso de intolerancia.
- En los pacientes con diabetes y obesidad, evitar fármacos que aumenten peso.
- Como en toda enfermedad crónica, el tratamiento farmacológico debe mantenerse a largo plazo, valorando eficacia y tolerancia.
- El tratamiento farmacológico, en muchos casos, precisa escalado de dosis hasta alcanzar la dosis máxima indicada o tolerada.